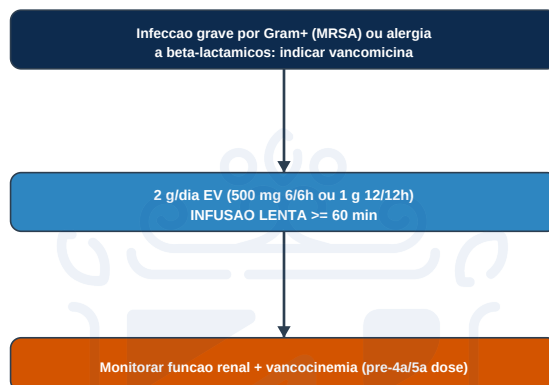


VANCOMICINA — MRSA + MONITORAR NÍVEL/RIM

FLUXOGRAMA — USO RACIONAL

VANCOMICINA — INDICAR -> INFUNDIR LENTO -> MONITORAR



INDICAÇÕES

QUANDO USAR

- Infecções estafilocócicas GRAVES em pacientes com hipersensibilidade a penicilinas/cefalosporinas
- Infecções por estafilococos RESISTENTES à meticilina/oxacilina (MRSA)
- Endocardite infecciosa
- Infecção de corrente sanguínea (bacteremia); osteomielite; abscesso pulmonar
- Erisipela/infecções de pele e partes moles graves com suspeita de MRSA

ADMINISTRAÇÃO

Rx DOSE E INFUSÃO

Dose habitual: 2 g/dia EV — dividida em 500 mg 6/6h ou 1 g 12/12h

INFUSÃO LENTA: mínimo de 60 minutos por dose (reduz o risco de síndrome do homem vermelho)

Ajustar a dose à função renal (a vancomicina é nefrotóxica e eliminada por via renal)

Considerar dose de ataque (loading) em infecções graves/sepses, conforme protocolo institucional

A dose ideal moderna é guiada pela meta de AUC; na ausência, usa-se o nível de vale (trough)

MONITORAMENTO

RIM + VANCOCINEMIA

- FUNÇÃO RENAL: monitoramento DIÁRIO, com cálculo do clearance (Cockcroft-Gault)
- Cockcroft-Gault — Homens: $CrCl = (140 - \text{idade}) \times \text{peso} / (Cr \text{ sérica} \times 72)$
- Mulheres: $CrCl = (140 - \text{idade}) \times \text{peso} \times 0,85 / (Cr \text{ sérica} \times 72)$
- VANCOCINEMIA (nível de vale): dosar antes da 4ª ou 5ª dose, 30-60 min ANTES da próxima dose
- Ajustar a dose conforme o nível sérico e a função renal; vigiar nefrotoxicidade (sobretudo com outros nefrotóxicos)

SÍNDROME DO HOMEM VERMELHO E EFEITOS ADVERSOS

RECONHECER E MANEJAR

- SÍNDROME DO HOMEM VERMELHO: ocorre quando a vancomicina é infundida MUITO RÁPIDO — erupção pruriginosa e eritematosa em face, pescoço e tronco superior ($\pm$ extremidades)
- NÃO é alergia mediada por IgE — é reação anafilactoide (liberação de histamina)
- Conduta: SUSPENDER a infusão + Difenidramina 50 mg VO/EV + antagonista H2 (ex.: cimetidina EV)
- Após a resolução, reiniciar a vancomicina em infusão MAIS LENTA (ao longo de 4 horas); considerar antibiótico alternativo se disponível
- Outros efeitos: nefrotoxicidade (vigiar creatinina), ototoxicidade (raro); prevenir a síndrome do homem vermelho com infusão ≥ 60 min

PONTOS-CHAVE PARA O PLANTÃO

RESUMO

- Reservar a vancomicina para MRSA/Gram+ grave ou alergia a beta-lactâmicos (uso racional)
- Sempre infundir LENTO (≥ 60 min) para prevenir a síndrome do homem vermelho
- Monitorar função renal diariamente e dosar vancocinemia antes da 4^a-5^a dose
- Ajustar a dose pela função renal; cuidado com associação de nefrotóxicos
- Descalonar conforme cultura/antibiograma assim que possível

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a principal indicação da vancomicina?

- A) Infecções por Gram-negativos entéricos
- B) Infecções graves por estafilococos resistentes à metilicina (MRSA) ou em alérgicos a beta-lactâmicos
- C) Infecções fúngicas
- D) Infecções virais
- E) Parasitoses

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Como prevenir a síndrome do homem vermelho durante a administração de vancomicina?

- A) Infundir em bolus rápido
- B) Infundir lentamente (mínimo de 60 minutos por dose)
- C) Associar corticoide de rotina
- D) Usar via intramuscular
- E) Reduzir a hidratação

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

A síndrome do homem vermelho associada à vancomicina é:

- A) Uma reação alérgica IgE-mediada que contraindica novo uso
- B) Uma reação anafilactoide por infusão rápida (liberação de histamina); manejar com suspensão + anti-histamínico e reintroduzir mais lentamente
- C) Sinal de falha terapêutica
- D) Uma infecção secundária
- E) Um efeito sem manejo possível

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quando deve ser colhida a vancocinemia (nível de vale)?

- A) 1 hora após a 1ª dose
- B) Antes da 4ª ou 5ª dose, 30-60 minutos antes da próxima dose
- C) Apenas ao final do tratamento
- D) Durante a infusão
- E) Não é necessário dosar

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual parâmetro deve ser monitorado diariamente durante o uso de vancomicina?

- A) Função tireoidiana
- B) Função renal (clearance de creatinina)
- C) Glicemia
- D) Função hepática isolada
- E) Coagulograma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A vancomicina é indicada em infecções graves por estafilococos resistentes (MRSA) ou em pacientes alérgicos a penicilinas/cefalosporinas, além de endocardite, bacteremia e osteomielite.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A síndrome do homem vermelho é prevenida com infusão lenta (mínimo de 60 minutos por dose), evitando a liberação rápida de histamina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

É uma reação anafilactoide por infusão rápida (liberação de histamina), não IgE-mediada; maneja-se com suspensão da infusão + difenidramina/anti-H2 e reintrodução mais lenta (em 4h).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A vancocinemia (nível de vale) é colhida antes da 4ª ou 5ª dose, 30-60 minutos antes da próxima administração, para ajuste de dose.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A função renal (clearance de creatinina pela fórmula de Cockcroft-Gault) deve ser monitorada diariamente, pela nefrotoxicidade e eliminação renal da vancomicina.

SM24
Suporte ao Plantão Médico